Az Érzelem–Stressz–Viselkedés (ESV) modell
és a Mentális Zavarok Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyve (DSM-5)

Összehasonlító tudományos elemzés

Szerző: Ódor Antal, független kutató

DOI: 10.5281/zenodo.19159344

ID: https://orcid.org/0009-0009-2027-3245

odor-antal@research.hu

Budapest, 2026

Történeti háttér és fejlődés

Az ESV-modell kialakulása

Az ESV-modell Ódor Antal független kutató nevéhez fűződik, első publikációi és szakmai kézikönyvei 2024–2025 között jelentek meg. A modell fejlesztése során a szerző rendszerelméleti és pszichobiológiai kutatásokat – különösen a polivagális elméletet (Porges, 2011) és a talamikus gátlás legfrissebb eredményeit (Acsády, 2025) – ötvözött azzal a személyes felismeréssel, hogy a hagyományos top-down diagnosztikus paradigma súlyos stresszhelyzetekben és traumafeldolgozás során korlátokba ütközik (Ódor, 2025d). A modell nem rendelkezik széles körben publikált irodalmi előzménnyel: az elméleti keret az érzelem–stressz–viselkedés triád elvére épül, de a négyváltozós, kódolt rendszer (A-P-H-C) és a 122 állapotkód Ódor önálló fejlesztése.

A DSM fejlődése

A Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) az Amerikai Pszichiátriai Társaság (APA) kiadványa, amelynek első változata 1952-ben jelent meg. A DSM-III (1980) hozta a legradikálisabb újítást: explicit diagnosztikus kritériumokat, az etiológiától független leíró szemléletet és a többtengelyes rendszert. A DSM-IV (1994) tovább finomította a kritériumrendszert és törekedett az ICD-10-zel való összhangra. A DSM-5 (2013) szakított a többtengelyes struktúrával, spektrumzavarokat vezetett be, és bevezette a keresztmetszeti tünetkérdőíveket, valamint a Kulturális Formulációs Interjút. A DSM-5-TR (2022) szövegfrissítéseket és néhány új diagnózist (pl. prolongált gyászzavar) tartalmaz. Minden kiadással a kategóriák száma nőtt: a DSM-I 106 diagnózist tartalmazott, a DSM-5 közel 300-at – és ez a szám strukturálisan nincs felső korláthoz kötve.

Elméleti alapok és kulcsfogalmak

Az ESV-modell elméleti kerete

Az ESV-modell a mentális állapotokat nem betegségkategóriákban, hanem az idegrendszer és a környezet dinamikus kölcsönhatásában értelmezi. A modell négy funkcionális változója:

- A(t) – Arousal (belső feszültség): az aktuális érzelmi telítettség és a limbikus rendszer aktivációs szintje. A STAI állapot-skála alapján operacionalizálva.
- P(t) – Protection (érzelemszabályozás, inverz logikájú): a megküzdési kapacitás és a vegetatív idegrendszeri egyensúly mutatója. Magas értéke erős védelmet jelez. A DERS alapján, inverz számítással.
- H(t) – Hardship (észlelt stressz): a környezeti terhelés és a szubjektív nyomás mértéke. A PSS alapján.
- C(t) – Condition (szomatikus tünetek): a pszichés terhelés testi manifesztációja. A PHQ-15 alapján.

Az elmélet körkörös kauzalitásra épül: a mentális szenvedést nem egy külső esemény önmagában, hanem egy önfenntartó visszacsatolási hurok (feedback loop) tartja fenn, amelyben az érzelmi válasz, a stresszreakció és a viselkedés egymást erősíti még az eredeti kiváltó ok elmúltával is. Ez a 'pszichés kényszerhurok' neurobiológiai szubsztrátja a talamikus beragadási mechanizmus (Acsády, 2025), amely magyarázza az arousal tartós emelkedettségét a stresszor megszűnése után is.

Az ESV-modell explicit neurobiológiai pilléreken nyugszik: a polivagális elmélet (Porges, 2011) ventrális vágusz / szimpatikus aktiváció / dorzális vágusz hierarchiája közvetlen elméleti megfelelője az ESV négy arousal-szintjének, és biztosítja, hogy a modell kódjai ne önkényes kategóriák, hanem az autonóm idegrendszer fiziológiailag megalapozott állapotait tükröző leírások legyenek.

A DSM elméleti kerete

A DSM szemlélete elsődlegesen leíró és kategorikus: a mentális zavarokat meghatározott tünetegyüttesek jelenlétéhez köti. A DSM-5 definíciója szerint a mentális zavar olyan pszichológiai vagy viselkedéses tünetegyüttes, amely szenvedést vagy funkcionális zavart okoz. A kézikönyv nem kapcsolódik egyetlen átfogó neurobiológiai vagy pszichológiai elmélethez – szándékoltan elméletfüggetlen (theory-neutral), hogy különböző iskolák képviselői egyaránt alkalmazni tudják. A diagnózis politetikus logikát alkalmaz: egy diagnózishoz az előírt tünetlista meghatározott számának kell teljesülnie, meghatározott időtartamon át, kizáró kritériumok fennállása nélkül. A DSM-5 bevezetett dimenziális elemeket is (pl. súlyossági skálák, spektrumzavarok), de alapstruktúrája kategorikus maradt.

Architektúrális különbség: véges zárt rendszer vs. nyílt bővülő lista

Az egyik legfontosabb – és az összehasonlításokban eddig kevéssé hangsúlyozott – strukturális különbség a két rendszer között az, hogy az ESV-modell matematikailag zárt, véges számú elemet tartalmaz, míg a DSM elvileg nyílt végű, folyamatosan bővülő diagnózislista.

A DSM nyílt, bővülő architektúrája

A DSM minden kiadásával nő a diagnózisok száma: a DSM-I 106, a DSM-III közel 265, a DSM-IV-TR mintegy 297, a DSM-5 pedig körülbelül 300 diagnózist tartalmaz. A rendszer struktúrája nem szab felső korlátot az új kategóriák bevezetésének. Minden revíziós ciklus során munkabizottságok javasolhatnak új zavarosztályokat, ha az epidemiológiai és klinikai evidencia alátámasztja azokat. Ez a nyílt architektúra előnyökkel is jár – rugalmas és képes alkalmazkodni az új kutatási eredményekhez –, de egyúttal feszültségeket is teremt: a diagnózisok inflálódásának kockázata, a false positive arányok emelkedése, és az a kritika, hogy a normalitás egyre több aspektusa kerül patológiás kategória alá.

A DSM nyílt rendszerének egy további következménye, hogy a diagnosztikus határok nem egymásból következő matematikai logikán, hanem szakkonszenzuson és szavazáson alapulnak. Ez lehetővé teszi a tudományos fejlődésre való reagálást, de egyben a rendszer belső konzisztenciáját is behatárolja.

Az ESV zárt, véges matematikai rendszere

Az ESV-modell ezzel szemben matematikailag zárt rendszer. A négy változó (A, P, H, C) mindegyike 1-től 4-ig terjedő skálán kódolt, ami elméletileg $4^4 = 256$ lehetséges kombinációt eredményez. A fiziológiai inkompatibilitás elvének alkalmazásával (bizonyos kombinációk a gyakorlatban nem fordulnak elő az emberi szervezet működési logikája alapján), a dominanciaelv alkalmazásával (kritikus állapotokban egy változó annyira domináns, hogy a többi finomhangolása már nem változtat érdemben az intervención), és a Protection-változó elfedő hatásának figyelembevételével (magas P képes kompenzálni és elrejteni más mutatók szélsőségeit) a 256 lehetséges kódból 122 releváns, funkcionálisan értelmezhető és specifikus intervenciót igénylő állapotkód maradt.

Ez a 122 kód rögzített és kiadásról kiadásra nem változik – a rendszer belső logikájából következik, és nem szakkonszenzus vagy szavazás eredménye. Ez biztosítja a belső konzisztenciát és az algoritmikus reprodukálhatóságot: ugyanazon input (A, P, H, C értékek) minden esetben ugyanazon kódot és ugyanazon intervenciós protokollt eredményezi. A modell így nem bővíthető 122 fölé anélkül, hogy a négyváltozós struktúra módosulna.

Összehasonlítás: a két architektúra implikációi

Szempont	DSM-5(-TR)	ESV-modell
Elemszám	~300 diagnózis (DSM-5); folyamatosan bővülő	122 rögzített funkcionális állapotkód; matematikailag zárt
Bővíthetőség	Elvileg korlátlan; minden revízióval nőhet a diagnózisok száma	Rögzített; új elem csak a négyváltozós struktúra módosításával lehetséges

Szempont	DSM-5(-TR)	ESV-modell
Meghatározás alapja	Szakkonszenzus, munkacsoporti szavazás, evidenciafelülvizsgálat	Matematikai kombinátorika + fiziológiai inkompatibilitás- és dominanciaelv
Belső konzisztencia	Nem algoritmikus; kategóriák közötti határok vita tárgyát képezhetik	Algoritmikus; azonos input → azonos kód és intervenciós protokoll
Inflálódás kockázata	Magas; minden kiadással növekszik a diagnózisok száma	Nincs; a kódok száma matematikailag maximálva
Rugalmasság	Magas; képes befogadni új kutatási eredményeket és kulturális adaptációkat	Alacsonyabb; a struktúra változtatása a teljes rendszer újrakalkulálását igényli

Diagnosztikus struktúra és kritériumok

A DSM-5 struktúrája

A DSM-5 a mentális zavarokat nagy fejezetekbe csoportosítja (neurózisok, hangulatzavarok, szkizofréniaspektrum, neurofejlődési zavarok, személyiségzavarok stb.). Minden zavarhoz meghatároz egy vagy több diagnosztikus kritériumcsoportot, amelyek tünetek felsorolásán alapulnak. Egy diagnózis felállításához a tünetek meghatározott száma és időtartama szükséges, kizáró kritériumokkal kombinálva. A DSM-5 bevezette a 'cross-cutting' transzdiagtikus tünetkérdőíveket és a Kulturális Formulációs Interjút, de fő struktúrája kategorikus marad.

A diagnózisok politetikus logikája azt jelenti, hogy pl. a major depresszív epizód diagnózisát 9 tünetből legalább 5 teljesülése esetén lehet felállítani – ebből matematikailag 256 tünetkombináció jelenti 'ugyanazt' a diagnózist, miközben két beteg tünetprofilja akár egyetlen átfedő elemet sem tartalmaz. Ez a belső heterogenitás a DSM kategorikus architektúrájának strukturális következménye.

Az ESV funkcionális kódrendszere

Az ESV nem betegségkategóriákat, hanem négyjegyű funkcionális állapotkódokat alkalmaz (A–P–H–C formátum, ahol minden változó 1-től 4-ig terjed). Az értékeket a négy validált mérőeszköz (STAI, DERS, PSS, PHQ-15) alapján számított normalizált [0,1] indexek 4-fokú skálára konvertálásával kapjuk, meghatározott küszöbértékek (cut-off points) alapján: 0,00–0,30 = 1 (low), 0,31–0,60 = 2 (normal), 0,61–0,80 = 3 (elevated), 0,81–1,00 = 4 (critical). A P(t) változó inverz logikájú: magas érték erős védelemet, alacsony érték sérülékeny

szabályozást jelöl.

A 122 kódból álló teljes spektrum négy főcsoportba szerveződik: 1000-es sorozat (alacsony arousal: nyugalom és lefagyás), 2000-es sorozat (közepes arousal: aktivitás és szorongás), 3000-es sorozat (emelkedett arousal: túlműködés és kompenzáció), 4000-es sorozat (kritikus arousal: krízis és összeomlás). Minden kódhoz részletes helyzetleírás, klinikai indoklás és irányadó intervenciós protokoll tartozik.

Módszertan és operacionalizáció

Az ESV-25 Inventory

Az ESV-modell mérőeszköze az ESV-25 kérdőív, amely a négy validált skála (STAI, DERS, PSS, PHQ-15) rövidített, faktoranalízissel szűrt és a magyar nyelvi környezetre adaptált tételeiből épül fel. A kérdőív összesen 25 tételt tartalmaz: A(t) = 6 tétel, Likert (1–5); P(t) = 6 tétel, Likert (1–5), inverz; H(t) = 4 tétel, Likert (1–5); C(t) = 5 tétel, súlyozott (0–2). A nyers pontszámokat [0,1] intervallumra normalizált indexekké alakítják, majd 4-fokú skálára kódolják. A kapott négyjegyű ESV-kód alapján a funkcionális állapotleíró kézikönyv irányadó intervenciós protokollt rendel az adott állapothoz.

A DSM módszertana

A DSM nem kínál saját mérőeszközt; a diagnózisok felállításához strukturált vagy félstrukturált klinikai interjúk (SCID, MINI, K-SADS) szükségesek. Emellett a DSM-5 bevezette a WHODAS 2.0 funkcionális értékelőt (a korábbi GAF helyett) és cross-cutting symptom skálákat a szűrőfázishoz. A diagnózisok validálásához kontrollcsoportos vizsgálatok, prospektív epidemiológiai felmérések és mezőpróbák (field trial) szolgálnak. A DSM-5 field trial-ok során kappa-számítással mérték a klinikusok közötti diagnózisegyezést.

Empirikus bizonyítékok és validáció

Az ESV-modell empirikus háttere

Az ESV-modell validációja két fő fázisban zajlott:

Pilot vizsgálat (N=13, 2025): 13 fős mintán (8 nő, 5 férfi; életkor: 21–75 év, átlag: 48,6 év) kérdőíves módszerrel végzett vizsgálat. A Pearson-féle korrelációs elemzés szignifikáns összefüggéseket tárt fel a négy változó között, különösen az A–P ($r = –0,647$; $p = 0,031$), az A–H ($r = +0,614$; $p = 0,031$) és a P–H ($r = –0,773$; $p = 0,005$) tengelyeken. A C(t) szomatikus tünetek változója gyengébb kapcsolatot mutatott, ami konzisztens a 'testi késleltetés' elméleti tézisével.

Változópárosítás (N=13)	r	p-érték
A(t) – P(t)	–0,647	0,031 *
A(t) – H(t)	+0,614	0,031 *
A(t) – C(t)	+0,575	0,044 *
P(t) – H(t)	–0,773	0,005 **
P(t) – C(t)	–0,262	0,064 (n.s.)
H(t) – C(t)	+0,346	0,437 (n.s.)

* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; n.s. = nem szignifikáns

Kibővített validáció (N=53, 2025): Az ESV-25 Inventory alkalmazásával N=53 fős mintán végzett struktúrális validáció. A korrelációs mátrix kiemelt eredményei:

	A(t)	P(t)	H(t)	C(t)
A(t)	1,000	–0,778	+0,755	+0,568
P(t)	–0,778	1,000	–0,685	–0,439
H(t)	+0,755	–0,685	1,000	+0,593
C(t)	+0,568	–0,439	+0,593	1,000

A Cronbach-alfa belső megbízhatósági értékek: A(t) = 0,89 (jó); P(t) = 0,91 (kiváló); H(t) = 0,86 (jó); C(t) = 0,79 (elfogadható). A P-skála szórása a legmagasabb (SD = 0,830), empirikusan alátámasztva a modell alaptézisét: az emberek közötti legfőbb különbség nem a terhelés mértékében, hanem a szabályozási kapacitásban mutatkozik. A t-tesztes szignifikanciaellenőrzés (df = 51) az A–P tengelyen $t = –8,851$; $p = 6,978 \times 10^{-12}$, az A–H tengelyen $t = 8,220$; $p = 6,588 \times 10^{-11}$ erősen szignifikáns eredményt adott.

Kvalitatív terepi validáció (2025): Öthetes, kvalitatív terepmunka gyógypedagógiai alsó tagozatos csoportban speciális nevelési igényű tanulókkal. Az eredmények gyors csoportszintű stabilizálódást, az önszabályozási, bizalmi és koreguláció készségek fejlődését jelezték (Ódor, 2025b). A vizsgálat kvalitatív és nem reprezentatív, de a modell pedagógiai alkalmazhatóságát kvalitatív adatokkal támasztja alá.

A DSM-5 empirikus háttere

A DSM évtizedes empirikus bázison nyugszik. A DSM-5 field trial-ok (Regier et al., 2013) eredményei szerint a vizsgált diagnózisok interklinikai megbízhatósága (κ) vegyes képet mutatott: 5 diagnózis esett a 'nagyon jó' (κ = 0,60–0,79) kategóriába, 9 a 'jó' (κ = 0,40–0,59) tartományba, 6 'kérdéses' (κ = 0,20–0,39) és 3 'elfogadhatatlan' (κ < 0,20) megbízhatóságú volt. Ez azt jelzi, hogy a DSM-5 kritériumrendszer többsége viszonylag stabil, de egyes diagnosztikus kategóriákban – különösen a spektrumzavaroknál – számottevő bizonytalanság maradt. Számos epidemiológiai felmérés, neurobiológiai kutatás és terápiás hatékonyságvizsgálat erősíti meg a főbb diagnózisok validitását.

Erősségek, gyengeségek és kritikai viták

Az ESV-modell erősségei

- Rendszerszemlélet és körös kauzalitás: nem betegséget, hanem funkcionális folyamatot azonosít; képes a tünetek mögötti mechanizmusokra rálátni.
- Prevenciós fókusz: az elevated zóna kódjai szubklinikai állapotokat is jeleznek, lehetővé téve a beavatkozást a klinikai küszöb elérése előtt.
- Matematikai zártság és konzisztencia: 122 rögzített kód, algoritmikus reprodukálhatóság, diagnóziscímke-inflálódás nélkül.
- Explicit neurobiológiai alap: a polivagális elmélet és a talamikus szűrés mechanizmusainak integrálása elméleti koherenciát biztosít.
- Dinamikus állapotkövetés: az ESV-kód időbeli változásainak nyomon követése lehetővé teszi az intervenció hatékonyságának mérését rövid időhorizonton.
- 'Közös nyelv' a segítő szakmákban: az érzelmi és szomatikus folyamatok összefüggéseit egységes keretben kommunikálja pedagógusok, tanácsadók, mentálhigiénés szakemberek számára.

Az ESV-modell gyengeségei és korlátai

- Korlátozott empirikus validáció: a rendelkezésre álló vizsgálatok kis elemszámúak és részben publikálatlanok; nagyobb, reprezentatív, kontrollcsoportos vizsgálatok még szükségesek.
- Normaadatok hiánya: jelenleg nem áll rendelkezésre populációs szintű referenciaadat, ami limitálja az egyéni eredmény értelmezhetőségét.
- Kulturális validáció hiánya: a modell magyar fejlesztésű és elsősorban magyar környezetben tesztelt; más kultúrákra való alkalmazhatósága empirikusan nem igazolt.
- Hivatalos elismerés hiánya: nincs WHO- vagy APA-akkreditáció; a segítő szakmában kiegészítő eszközként, nem orvosi diagnózisként alkalmazható.
- A komplexitás tanulási igénye: a 122 kód és a kapcsolódó protokollok elsajátítása

szakmai képzést igényel.

A DSM-5 erősségei

- Globális szabvány: a pszichiátria és klinikai pszichológia világszerte elfogadott diagnosztikai referenciakeretrendszere; kódjai beépültek a biztosítási és jogi rendszerekbe.
- Kiterjedt empirikus bázis: évtizedes kutatási háttér, epidemiológiai adatok, farmakológiai és pszichoterápiás hatékonyságvizsgálatok.
- Dinamikus fejlesztés: rendszeres evidenciafelülvizsgálat és revízió; a tudományos fejlődésre reagáló struktúra.
- Kulturális integráció: Kulturális Formulációs Interjú, etnorasszista egyenlőségi felülvizsgálat (DSM-5-TR), kultúraspecifikus distressz-koncepciók.
- Kommunikációs eszköz: egységes terminológia klinikusok, kutatók, egészségügyi adminisztrációk és biztosítók között.

A DSM-5 gyengeségei és kritikai viták

- Patológiásítás kockázata és diagnózisinfláció: a diagnózisok számának folyamatos növekedése a normalitás spektrumának szűküléséhez és a false positive arányok emelkedéséhez vezet (Wakefield, 2013; Hyman, 2010).
- Belső heterogenitás: a politetikus diagnosztikus logika következtében ugyanazon diagnózison belül neurobiológiailag heterogén csoportok fordulhatnak elő, ami behatárolja a kezelési protokollok hatékonyságát.
- Érvényességi kérdések: a kategorikus határok mesterségességét és a természetes taxa hiányát Kendell és Jablensky (2003) részletesen elemezték; az RDoC-kezdeményezés részben erre a kritikára adott választ.
- Kulturális torzítások: bár a DSM-5 törekszik a kulturális szempontok integrálására, alapkategóriái nyugati pszichiátriai kontextusból erednek.
- Korlátozott dinamikus követés: a kategorikus diagnózis kevéssé alkalmas az állapotváltozások rövid időhorizonton való nyomon követésére.

A 122 kód és a ~300 diagnózis: rendszerfilozófiai összehasonlítás

Az ESV-modell és a DSM struktúrájának összehasonlítása a 'véges zárt rendszer vs. nyílt bővülő lista' tengelyen nem csupán technikai, hanem rendszerfilozófiai kérdést vet fel: mit tekintsünk a mentális állapotok osztályozásának megfelelő granularitási szintjének?

A DSM megközelítése azt tükrözi, hogy a mentális szenvedés sokfélesége alapvetően kategoriális természetű, és minden új, klinikailag elkülöníthető mintázat potenciálisan egy új diagnózist érdemel. Ez a szemlélet elvben a végtelen differenciálhatóság irányába mutat, és a rendszert az ismeretek bővülésével párhuzamosan nyitja. Az inflálódás kockázatát a revíziós

folyamat evidenciakövetelményei korlátozzák, de elvi felső határt nem szabnak.

Az ESV megközelítése ezzel szemben azt tükrözi, hogy a pszichés működés releváns dimenzióinak száma véges, és hogy a segítő intervenció szempontjából nem a tüneti sokféleség kategorizálása, hanem a funkcionális állapot néhány kulcsdimenzió mentén való precíz meghatározása a döntő. A 122 kód nem azért 122, mert a kutatók szükségszerűen megálltak ennél a számnál – hanem azért, mert a matematikai struktúra és a fiziológiai inkompatibilitás elve ezt a számot adja. Ez a zárt rendszer algoritmikus prediktabilitást és inflálódásmentességet biztosít, miközben a fejlesztés irányát nem a kategóriák számának növelésében, hanem a négy alapdimenzió mélyebb neurobiológiai megalapozásában és validálásában jelöli ki.

A két megközelítés nem egymást kizáró: egy integratív ellátórendszerben a DSM diagnózisai a klinikai döntéshozatal kategorikus referenciáját adják, míg az ESV-kódok az egyéni funkcionális dinamika dimenzionális feltérképezését végzik – egymás mellett, egymást kiegészítve.

Keresztkulturális megfontolások

A DSM kulturális szempontjai

A DSM-5 bevezette a Kulturális Formulációs Interjút (CFI), amely segíti a klinikusokat a páciens saját kulturális keretének megismerésében. A DSM-5-TR átfogó etnorasszista egyenlőségi felülvizsgálatot tartalmazott, és a Cultural Concepts of Distress kategória bevezette a kultúraspecifikus distressz-megnyilvánulásokat. Ennek ellenére a DSM alapkategóriái klasszikusan nyugati pszichiátriai kontextusból erednek, és számos szerző rámutatott, hogy egyes diagnózisok prevalenciabecslései kulturálisan eltérők.

Az ESV kulturális helyzetképe

Az ESV-modell jelenleg magyar fejlesztésű és főként magyar környezetben alkalmazott. A modell nem tartalmaz expliciten kulturális dimenziókat, és más kultúrákra vonatkozó adaptációs vizsgálatok még nem készültek. Előnye, hogy neurobiológiai alapjaira – az érzelemszabályozás és a stresszmechanizmusok elemi folyamataira – elvileg kulturálisan univerzális igény tarthat, de ezt empirikusan igazolni kell. Az interkulturális validáció a jövőbeli fejlesztés egyik kiemelt iránya.

Az integrációs modell: ESV és DSM az ellátórendszerben

Az ESV-modell és a DSM integrált alkalmazásának legegyszerűbb modellje a következő szekvencia:

- 1. szint – Funkcionális szűrés (ESV): segítő szakember elvégzi az ESV-25 felmérést. Az elevated zóna jelzése esetén fókuszált intervenció indul; critical zóna esetén kötelező a klinikai ellátásba irányítás.
- 2. szint – Klinikai diagnózis (DSM): pszichiáter vagy klinikai szakpszichológus elvégzi

a strukturált klinikai interjút (SCID) és felállítja a DSM-5 diagnózist.

– 3. szint – Terápiás monitorozás (ESV): a kezelés során az ESV-kód időbeli változása jelzi az intervenciók hatékonyságát dinamikusan, rövid időhorizonton.

Ez az analóg a vérnyomásmérés (dimenzionális, folyamatos monitor) és a hipertónia ICD/DSM szerinti diagnózisa (kategorikus küszöb) párhuzamos alkalmazásával: az előbbi monitorizál és figyelmeztet, az utóbbi a kezelési protokollt definiálja.

Az ESV kézikönyve ezt explicit módon rögzíti: 'az ESV-modell nem helyettesíti a BNO (ICD) vagy DSM szerinti klinikai diagnosztikát, sem a pszichiátriai szakvizsgálatot' – hanem a szupportív, mentálhigiénés és önismereti folyamatokat támogatja.

Átfogó összehasonlító táblázat

Jellemző	ESV-modell (Ódor, 2024–2026)	DSM-5(-TR) (APA, 2013/2022)
Alapvető funkció	Funkcionális állapotfelmérés és dinamikus folyamattérkép	Pszichiátriai zavarok kategorikus osztályozása és diagnosztikája
Elemszám / kódok	122 rögzített funkcionális állapotkód (matematikailag zárt)	~300 diagnózis (DSM-5); nyílt, bővülő; a DSM-I-hez képest háromszoros növekedés
Bővíthetőség	Nem bővíthető; a struktúra rögzített	Minden revíziós ciklusban nő; elvi felső korlát nincs
Ontológia	Dinamikus egyensúlyi rendszer; körkörös kauzalitás	Diszkrét entitások; tünetegyüttesek kategorikus leírása
Elméleti alap	Explicit: polivagális elmélet, talamikus szűrés, limbikus szabályozás	Elméletfüggetlen (theory-neutral); leíró-deskriptív
Mérőeszköz	ESV-25 önkitöltős kérdőív (STAI + DERS + PSS + PHQ-15 alapján)	Strukturált interjúk (SCID, MINI); standardizált skálák kiegészítőként
Eredmény formátuma	4-jegyű állapotkód + irányadó intervenciós protokoll	Diagnózis + ICD-kód + opcionális súlyossági szint
Időbeli jelleg	Dinamikus, állapot-alapú (State); rövid időhorizonton	Relatíve statikus; diagnózis

Jellemző	ESV-modell (Ódor, 2024–2026)	DSM-5(-TR) (APA, 2013/2022)
	követhető	minimum időtartamhoz kötött
Szubklinikai lefedés	Igen; elevated zóna (0,31–0,60) a klinikai küszöb alatti állapotokat is jelzi	Korlátozott; szubszindromális kategóriák csak néhány zavarhoz
Empíria – megbízhatóság	Cronbach-α = 0,79–0,91 (N=53); szignifikáns korrelációk pilot és kibővített mintán	Kappa = 0,20–0,79 zavarfüggően (N=13.000+ field trial); széles kutatási bázis
Prevenciós fókusz	Elsősorban elsődleges és másodlagos prevenció	Elsősorban másodlagos és harmadlagos (kialakult zavar kezelése)
Kulturális integráció	Hiányos; interkulturális validáció szükséges	CFI, kulturális distressz-koncepciók; DSM-5-TR egyenlőségi felülvizsgálat
Szükséges képzettség	Segítő szakemberek (pszichológus, coach, pedagógus)	Pszichiáter, klinikai szakpszichológus
Jogköri státusz	Funkcionális állapotfelmérés; nem orvosi eszköz	Klinikai diagnózis; jogi, biztosítási, terápiás vonatkozásokkal
Diagnóziscímke-inflálódás	Nincs; a kódok száma matematikailag rögzített	Kockázat fennáll; minden revíziós ciklus potenciálisan növeli a diagnózisok számát
Komplementaritás	'Hogyan működik most a rendszer?' – dinamikus monitorizálás	'Mi a diagnózis?' – klinikai kategorizálás és kezelési protokoll

Jövőbeli kutatási irányok és nyitott kérdések

Az ESV-modell fejlesztési prioritásai

- Nagyléptékű validáció (N > 300): konfirmatorikus faktorelemzés (CFA), normapopulációs referenciák, longitudinális prediktív validitás vizsgálata (ESV-kód → later DSM-diagnózis arány).
- Konvergens validitás: az ESV-kódok és a DSM-diagnosztikai csoportok közötti szisztematikus összefüggések feltárása klinikai mintán.
- Neurobiológiai korrelátumai: az ESV P(t) változó és a talamikus szűrőfunkciók objektív mérőeszközökkel (HRV, EEG) való igazolása.
- Interkulturális adaptáció: az ESV-25 fordítása és validálása más nyelvterületeken.
- Klinikai hatástanulmányok: kontrollcsoportos vizsgálatok, amelyek az ESV-vezérelt beavatkozás és a DSM-diagnózis alapú kezelés hatékonyságát hasonlítják össze.

A DSM fejlesztési kérdései

- Transzdimenziós besorolás: a HiTOP (Hierarchical Taxonomy of Psychopathology) és az RDoC dimenzionális szemléletének fokozottabb integrálása a diagnosztikus struktúrába.
- Belső heterogenitás csökkentése: politetikus diagnosztikai logika felülvizsgálata a neurobiológiailag homogénebb alcsoportok azonosítása érdekében.
- Diagnózisinfláció kontrollja: a revíziós folyamat metodológiai kereteinek megerősítése az új diagnózisok befogadásának evidenciaküszöb-emelésével.
- DSM–ICD konvergencia: az ICD-11 és DSM-5-TR közötti megfeleltetési munka folytatása a globális interoperabilitás érdekében.

Összegzés és következtetések

Az ESV-modell és a DSM összehasonlítása öt főbb megállapítást tesz lehetővé:

1. Különböző kérdésekre adnak választ. A DSM a 'Mi a diagnózis?' kérdésre válaszol – kategorizál, kódol és klinikai protokollt indít. Az ESV a 'Hogyan működik most a rendszer?' kérdésre válaszol – térképez, monitorozza a dinamikát és irányadó intervenciót javasol. A két kérdés komplementer, nem versengő.

2. Architektúrájuk alapvetően különbözik. A DSM nyílt, bővülő lista, amelynek kategóriái szakkonszenzuson alapulnak és elvi felső korlát nélkül gyarapodhatnak. Az ESV zárt, matematikai rendszer, amelynek 122 kódja a négyváltozós struktúra szükségszerű következménye – nem szavazás eredménye. Ez algoritmikus konzisztenciát, inflálódásmentességet és prediktábilis reprodukálhatóságot biztosít.

3. Az ESV a szubklinikai teret fedi le. A DSM elsősorban a klinikai küszöb felett lévő állapotokat kategorizálja. Az ESV elevated zónája pontosan azt a tartományt jelzi, ahol a prevenció még lehetséges – ez az ESV egyedülálló hozzájárulása a mentálhigiénés ellátórendszerhez.

4. Az ESV empirikus validációja ígéretes, de korai fázisban jár. A rendelkezésre álló adatok

(Cronbach-α = 0,79–0,91; erősen szignifikáns korrelációk N=53 mintán) kielégítő kiindulópontot nyújtanak, de a nagyléptékű, longitudinális és klinikai validáció még szükséges.

5. Az integráció a legjobb megközelítés. A DSM és az ESV nem felváltják, hanem kiegészítik egymást: az ESV a korai szűrés és a funkcionális monitorizálás eszköze, a DSM a klinikai diagnosztika és kezelési protokoll eszköze. Együttes alkalmazásuk átfogóbb és hatékonyabb ellátást tesz lehetővé, mint bármelyikük önmagában.

Irodalomjegyzék

- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). American Psychiatric Publishing. https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596

- American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text revision). American Psychiatric Publishing. https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787

- Biró, L., Buday, Z., Kóta, K., Lőrincz, S., & Acsády, L. (2025). Convergence and segregation of excitatory and inhibitory afferents in the paraventricular thalamic nucleus. The Journal of Neuroscience, 45(43), e0539252025. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0539-25.2025

- Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385–396. https://doi.org/10.2307/2136404

- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297–334. https://doi.org/10.1007/BF02310555

- Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26(1), 41–54. https://doi.org/10.1007/s10862-008-9102-4

- Hyman, S. E. (2010). The diagnosis of mental disorders: The problem of reification. Annual Review of Clinical Psychology, 6, 155–179. https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.3.022806.091532

- Insel, T., Cuthbert, B., Garvey, M., Heinssen, R., Pine, D. S., Quinn, K., Sanislow, C., & Wang, P. (2010). Research domain criteria (RDoC): Toward a new classification framework

for research on mental disorders. American Journal of Psychiatry, 167(7), 748–751. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2010.09091379

- Kendell, R., & Jablensky, A. (2003). Distinguishing between the validity and utility of psychiatric diagnoses. American Journal of Psychiatry, 160(1), 4–12. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.160.1.4

- Kökönyei, G., Urbán, R., Reinhardt, M., Józan, A., & Demetrovics, Z. (2014). The Difficulties in Emotion Regulation Scale: Factor structure and psychometric properties in Hungarian adults and adolescents. Journal of Clinical Psychology, 70(5), 1–14. https://doi.org/10.1002/jclp.22036

- Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. (2002). The PHQ-15: Validity of a new measure for evaluating the severity of somatic symptoms. Psychosomatic Medicine, 64(2), 258–266. https://doi.org/10.1097/00006842-200203000-00008

- Mátyás, F., Komlósi, G., Babiczky, Á., Kocsis, K., Barthó, P., Barsy, B., Dávid, C., Kanti, V., Porrero, C., Magyar, A., Szűcs, I., Clasca, F., & Acsády, L. (2018). A highly collateralized thalamic cell type with arousal-predicting activity serves as a key hub for graded state transitions in the forebrain. Nature Neuroscience, 21(11), 1551–1562. https://doi.org/10.1038/s41593-018-0251-9

- Ódor, A. (2024). Az ESV-Modell: Az Érzelem-Stressz-Viselkedés kapcsolata a függőségek mechanizmusában. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18067060

- Ódor, A. (2025a). Az Érzelem-Stressz-Viselkedés modell empirikus tesztelése: Egy kérdőíves pilotvizsgálat eredményei. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18069510

- Ódor, A. (2025b). Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell terepi alkalmazása gyógypedagógiai környezetben: Módszertani beszámoló. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18076570

- Ódor, A. (2025c). A talamokortikális kapuzási mechanizmusok funkcionális leképezése az ESV modellben: Transzlációs megközelítés a pszichodiagnosztikában. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18059802

- Ódor, A. (2025d). Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell – Integrált szakmai kézikönyv: Elmélet, diagnosztika és beavatkozás a funkcionális pszichológiában. Zenodo.

https://doi.org/10.5281/zenodo.18047810

- Ódor, A. (2026). ESV funkcionális elemzési kézikönyv: Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell funkcionális rendszere. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18175305

- Porges, S. W. (2011). The polyvagal theory: Neurophysiological foundations of emotions, attachment, communication, and self-regulation. W. W. Norton & Company. ISBN: 978-0-393-70700-7

- Regier, D. A., Narrow, W. E., Clarke, D. E., Kraemer, H. C., Kuramoto, S. J., Kuhl, E. A., & Kupfer, D. J. (2013). DSM-5 field trials in the United States and Canada, Part II: Test-retest reliability of selected categorical diagnoses. American Journal of Psychiatry, 170(1), 59–70. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2012.12070999

- Sipos, K., & Sipos, M. (1983). The development and validation of the Hungarian Form of the State-Trait Anxiety Inventory. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/232541526

- Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. (1970). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Consulting Psychologists Press.

- Stauder, A., & Konkolÿ Thege, B. (2006). Az Észlelt Stressz Kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 203–216. https://doi.org/10.1556/Mental.7.2006.3.4

- Suslin, I. (2025). The CBER Model: A systemic framework integrating cognition, emotion, behavior, and environment. CBER Model Series, Bucharest. https://doi.org/10.5281/zenodo.17486685

- Töreki, A., Köteles, F., & Csifcsák, G. (2021). Validation of the Hungarian PHQ-15: A latent variable approach. Ideggyógyászati Szemle, 74(5–6), 183–192. https://doi.org/10.18071/isz.74.0183

- Van der Kolk, B. A. (2014). The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma. Viking. ISBN: 978-0-670-78593-3

- Wakefield, J. C. (2013). DSM-5: An overview of changes and controversies. Clinical Social

Work Journal, 41(2), 139–154. https://doi.org/10.1007/s10615-013-0445-2